ISTRUZIONE DI LAVORO

PIANO DI GESTIONE E CONTROLLO INFEZIONE MALATTIA DA VIRUS EBOLA NEGLI OSPEDALI DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

INTRODUZIONE

La malattia da virus Ebola (MVE) è una zoonosi ad elevata gravità causata da virus appartenenti al genere Orthoebolavirus. Le evidenze disponibili indicano come probabile serbatoio naturale alcune specie di pipistrelli frugivori. Il passaggio del virus all'uomo può verificarsi attraverso il contatto diretto con animali infetti o con i loro tessuti, mentre la successiva diffusione interumana avviene mediante esposizione a sangue, secrezioni, fluidi biologici, organi o materiali contaminati.

Il periodo di incubazione varia generalmente tra 2 e 21 giorni. Le persone infette non risultano normalmente contagiose fino alla comparsa della sintomatologia. Le manifestazioni cliniche iniziali sono poco specifiche e comprendono febbre, marcata debolezza, mialgie, cefalea e mal di gola, rendendo talvolta complessa l'identificazione precoce della malattia. Con l'evoluzione del quadro clinico possono insorgere vomito, diarrea, insufficienza multiorgano e, in una quota di casi, fenomeni emorragici.

Tra le specie di Orthoebolavirus patogene per l'uomo, lo Zaire ebolavirus è stato responsabile della maggior parte delle grandi epidemie registrate nel continente africano negli ultimi decenni, interessando in particolare la Repubblica Democratica del Congo (RDC), l'Uganda, la Guinea, la Sierra Leone e la Liberia.

In data 15 maggio 2026, il Ministero della Salute Pubblica, dell'Igiene e del Welfare Sociale della Repubblica Democratica del Congo e il Ministero della Salute dell'Uganda hanno notificato un focolaio epidemico di malattia da virus Ebola attribuito al Bundibugyo ebolavirus, con casi confermati in entrambi i Paesi.

La malattia da virus Bundibugyo (Bundibugyo Virus Disease – BVD) costituisce una forma severa di infezione da Ebola, caratterizzata da elevata mortalità. Nelle epidemie documentate in Uganda e nella RDC nel 2007 e nel 2012, il tasso di letalità è risultato compreso approssimativamente tra il 30% e il 50%.

A differenza della malattia sostenuta da Zaire ebolavirus, per la quale sono oggi disponibili vaccini e trattamenti basati su anticorpi monoclonali in grado di ridurre significativamente la mortalità, non esistono attualmente vaccini o terapie specifiche con efficacia comprovata contro il Bundibugyo ebolavirus.

In considerazione dell'elevata patogenicità del virus, dell'assenza di misure preventive e terapeutiche specifiche e del potenziale rischio di trasmissione in ambito sanitario, l'identificazione anche di un singolo caso sospetto impone l'immediata applicazione di rigorose procedure di isolamento e di biocontenimento, finalizzate alla tutela degli operatori sanitari, degli altri pazienti e della comunità.

SCOPO

La presente istruzione operativa definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione dei pazienti con sospetta o confermata infezione da virus Ebola. L'obiettivo è prevenire e contenere la diffusione dell'agente infettivo all'interno dell'Azienda USL Toscana Centro attraverso la tempestiva individuazione dei casi e l'attivazione delle misure assistenziali, organizzative e di isolamento necessarie fin dal loro eventuale accesso al Pronto Soccorso.

Questa versione adotta un registro più istituzionale e coerente con le procedure aziendali e i documenti sanitari ufficiali, mantenendo inalterato il contenuto tecnico-scientifico.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione è applicata da tutti gli operatori ATC nei setting Pronto Soccorso dell'Azienda USL Toscana Centro.

RIFERIMENTI

- Circolare del Ministero della Salute n. 3 dell'8 maggio 2003 —Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici

- Circolare del Ministero della Salute n. 26116 del 4 Settembre 2019 —Malattia Virus Ebola (MVE) – Aggiornamento del protocollo centrale di gestione dei casi e dei contatti"

- Circolare del Ministero della Salute n. 1894 del 18 maggio 2026 "Disease outbreak news - malattia da ebola causata da virus bundibugyo repubblica democratica del Congo e Uganda"

- Circolare del Ministero della Salute n. 3721 del 18 maggio 2026 "Epidemia di Malattia da Virus Bundibugyo BVD- (Orthoebolavirus bundibugyoense) nella Repubblica Democratica del Congo - RDC Attivazione della sorveglianza sanitaria al personale, sanitario e non, impiegato in attività di cooperazione/supporto sanitario o logistico presso organizzazioni governative, non governative, e cooperanti, che erogano servizi di tipo sanitario, assistenziale e logistico, impiegati nelle zone del Paese interessate dal focolaio"

- Ministero della Salute, Ordinanza 29 maggio 2026. GU n.123 del 29-5-2026 —Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative allaMalattia da Virus Ebola (MVE)‖

- Circolare del Ministero della Salute n. 4258 del 29 maggio 2026 "Malattia da Virus Ebola (MVE) causata dal virus Bundibugyo (Bundibugyo virus disease - BVD; Orthoebolavirus bundibugyoense) - Indicazioni operative per l'attuazione dell'Ordinanza del Ministro della salute "Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola (MVE)" del 29 maggio 2026 in materia di autosegnalazione, sorveglianza sanitaria, stratificazione del rischio e gestione dei casi, dei contatti di caso e dei soggetti in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda."

- Rapid ECDC advice on infection prevention and control measures for Ebola disease in EU/EEA healthcare settings del 2 giugno 2026

- Procedura operativa per la gestione sanitaria dei casi di malattia da virus Ebola del Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero della Salute del 6 giugno 2026

- PA.DRO.01 Gestione del paziente colonizzato/infetto in ambiente ospedaliero

- PA.DRO.12 Il codice colore come strumento di Infection Control

- PA.DLAB.01 Centrale di governo della logistica. Trasporti materiali biologici

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

BDBV: Virus Bundibugyo

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale

ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control

MVE Malattia da Virus Ebola

PS: Pronto Soccorso

RDC: Repubblica Democratica del Congo

DEFINIZIONI E MISURE DI GESTIONE

Di seguito si riportano le definizioni indicate nella Circolare del Ministero della Salute n. 4258 del 29 maggio 2026, nella quale è specificato che le misure di gestione si applicano a chiunque faccia ingresso nel territorio nazionale, indipendentemente dalla nazionalità, provenendo, direttamente o indirettamente, dalla RDC o dall'Uganda, ovvero sia stato nei medesimi Paesi nei 21 giorni precedenti l'ingresso in Italia.

DEFINIZIONE E GESTIONE DI CASO DI INFEZIONE DA MVE

La presente definizione ha lo scopo di classificare i casi di malattia da virus Ebola a fini epidemiologici e si applica ai casi associati al focolaio in corso causato dal virus Bundibugyo (BDBV) nella RDC e in Uganda.

La definizione di caso si basa su criteri clinici, epidemiologici, di laboratorio e di esposizione ad alto rischio, consentendo di distinguere i casi sospetti, probabili e confermati.

Tabella 1 - Criteri per la definizione di caso

Criterio	Descrizione
Epidemiologico	Nei 21 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi: soggiorno in un'area interessata dal focolaio (vedi nota); OPPURE contatto con un caso probabile o confermato di MVE.
Clinico	Qualsiasi persona che presenti o abbia presentato prima del decesso: febbre ≥38,6°C E almeno uno tra: cefalea intensa, vomito, diarrea, dolore addominale, manifestazioni emorragiche inspiegabili, insufficienza multiorgano. OPPURE una persona deceduta improvvisamente e senza causa apparente.
Laboratorio	Almeno uno dei seguenti: rilevazione di acido nucleico del BDBV in un campione clinico, con conferma mediante sequenziamento o un secondo test; isolamento di BDBV da campione clinico. La conferma diagnostica è di competenza esclusiva del

	Laboratorio Nazionale di Riferimento (INMI «Lazzaro Spallanzani», Roma — h24).

NOTA: La Circolare ministeriale definisce —area specifica di attenzionell una zona geografica nella quale sia documentata o ritenuta possibile una trasmissione del virus, ovvero un'area per la quale, in ragione del rischio epidemiologico, della mobilità della popolazione o di altre valutazioni di sanità pubblica, sia indicata una valutazione rafforzata dei viaggiatori nei 21 giorni successivi all'uscita dall'area. Le aree di specifica attenzione individuate sono disponibili al link https://www.ecdc.europa.eu/en/ebola-virus-disease-outbreak-democratic-republic-congo-and-uganda.

Tabella 2 — Stratificazione del rischio dell'esposizione

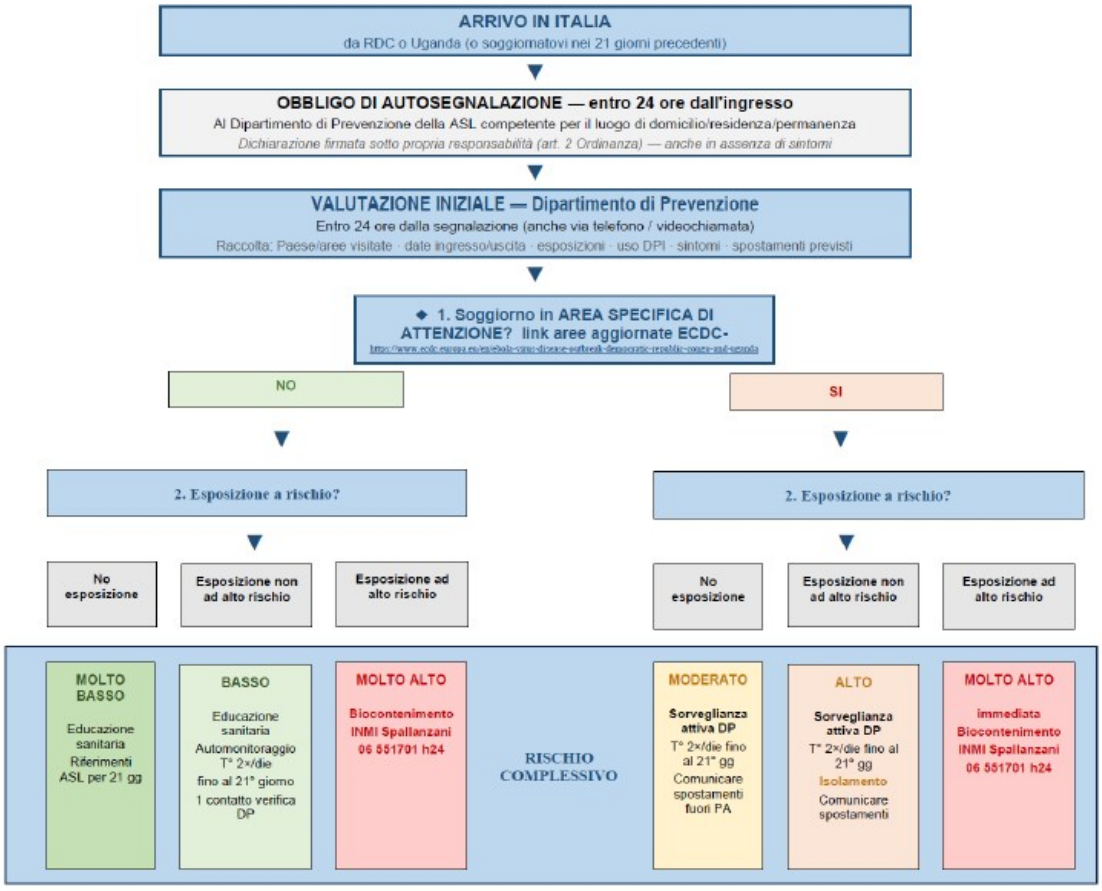
Livello rischio	Descrizione esposizione
Basso rischio	Contatti casuali con un paziente febbrile, autonomo, in grado di deambulare: Esempi sala di attesa, mezzo pubblico o privato di trasporto incluso il mezzo aereo fuori dalla zona di vicinanza definita, contatti brevi in transito, nei porti o occasionali, ufficio, reception, albergo, persone che condividono ampi spazi all'aperto senza interazioni prolungate, operatori sanitari e altro personale che utilizzano DPI adeguati per tutta la durata dell'esposizione
Alto rischio	Persona che soddisfa il criterio epidemiologico E almeno una delle seguenti condizioni: contatto ravvicinato (entro un metro) senza adeguati DPI con caso probabile/confermato sintomatico (tosse, vomito, sanguinamento, diarrea); contatto sessuale non protetto fino a 3 mesi dalla guarigione; contatto diretto con materiale contaminato da liquidi biologici; esposizione percutanea o mucosale a liquidi biologici/tessuti/campioni; riti funebri con esposizione a resti umani da aree colpite senza DPI; contatto con pipistrelli/roditori/primati non umani da aree colpite o consumo di carne di animali selvatici .

Tabella 3 — Classificazione dei casi

Categoria	Criteri di classificazione	Misure operative di gestione
Caso sospetto	Criterio clinico + Criterio epidemiologico OPPURE Esposizione ad alto rischio con ≥1 sintomo (inclusa febbre di qualsiasi grado)	Avviare immediatamente accertamento diagnostico. Notifica al Ministero della Salute e al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente. Isolamento precauzionale in attesa dell'esito.
Caso probabile	Criterio clinico + Criteri di esposizione ad alto rischio	Gestione come caso confermato in attesa di conferma di laboratorio. Non oggetto di notifica obbligatoria europea.
Caso confermato	Criteri di laboratorio soddisfatti (indipendentemente dal quadro clinico o epidemiologico).	Trasferimento in alto biocontenimento presso centro nazionale di riferimento.

CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI VIAGGIATORI ASINTOMATICI IN RIENTRO DA CONGO E UGANDA

Di seguito è riportata la classificazione del rischio dei viaggiatori asintomatici in rientro dalla RDC e dall'Uganda e le relative misure gestionali da adottare per 21 giorni dall'ultima esposizione, come previsto dalla flow-chart A della Circolare del Ministero della Salute n. 4258 del 29 maggio 2026.



In caso di comparsa di sintomi compatibili con MVE il soggetto deve:

- Autoisolarsi immediatamente,
- Evitare contatti con conviventi e terzi,
- Non recarsi autonomamente presso strutture sanitarie,
- Contattare immediatamente il Dipartimento di Prevenzione e il numero unico di emergenza 112/118.

MODALITA’ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN AUTOPRESENTAZIONE AI PS DELL’AZIENDA TOSCANA CENTRO

Negli ospedali dell’Azienda USL Toscana Centro non sono presenti spazi assistenziali con caratteristiche strutturali, impiantistiche e organizzative idonee alla gestione di pazienti affetti da infezioni da agenti biologici del Gruppo 4 ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., quali il virus Ebola.

Il Settore Prevenzione, Sicurezza sul Lavoro e Sanità Pubblica della Regione Toscana, con nota del 18/05/2026, ha individuato l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer quali strutture regionali di riferimento tra le strutture sanitarie provviste di misure di contenimento per la gestione di agenti biologici del gruppo 3 ai quali vanno inviati i casi sospetti ad alto rischio in attesa della conferma diagnostica.

Pertanto, i Pronto Soccorso dell’Azienda USL Toscana Centro garantiscono esclusivamente le attività di identificazione precoce, isolamento, valutazione clinica iniziale, stabilizzazione e trasferimento protetto del paziente verso i centri di riferimento.

Di seguito si riportano le modalità operative da adottare nella gestione dei casi con sospetta o probabile MVE e i percorsi assistenziali previsti per i pazienti che si presentano in PS.

Tali indicazioni saranno aggiornate in relazione all’evoluzione dello scenario epidemiologico e alle disposizioni nazionali e regionali.

PAZIENTE IN AUTOPRESENTAZIONE AL PRONTO SOCCORSO

<u>Identificazione del caso sospetto</u>

In tutti i pazienti che accedono al Pronto Soccorso con sintomi compatibili con MVE devono essere ricercati eventuali criteri epidemiologici di rischio, con particolare riferimento a:

soggiorno o permanenza in aree interessate da trasmissione di MVE nei 21 giorni precedenti;

contatto con casi sospetti o confermati;

esposizione a materiali biologici potenzialmente contaminati;

partecipazione ad attività assistenziali, funerarie o di laboratorio in aree interessate.

I soggetti con sospetta o probabile MVE che si presentano autonomamente al PS o giungono con i mezzi di soccorso, dovranno essere immediatamente allocati nello spazio di isolamento previsto nel presidio e assistiti nel rispetto delle misure di precauzione sotto descritte.

<u>Attività dell’infermiere di triage</u>

Qualora venga identificato un caso sospetto:

L’infermiere di triage informa il paziente che la valutazione dovrà avvenire in condizioni di isolamento e che dovrà mantenersi a distanza dagli altri utenti e dagli operatori.

L’infermiere indossa immediatamente:

- camice DPI di III categoria certificato per rischio biologico e chimico tipo 4B;
- guanti medicali monouso a manichetta lunga certificati per rischio biologico e chimico di III categoria;
- visiera protettiva a copertura completa del volto.

Tale dotazione minima consente di accompagnare in sicurezza il paziente nell’area di isolamento qualora non rispetti le indicazioni impartite o si avvicini accidentalmente all’operatore.

L’infermiere allerta immediatamente il capoturno che provvede a:

- informare la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero (DMPO);
- informare il Direttore del DEA;
- attivare la ditta incaricata delle operazioni di decontaminazione e sanificazione degli ambienti eventualmente interessati dal passaggio o dalla permanenza del caso sospetto;
- individuare il personale che dovrà effettuare la vestizione completa con DPI NBCR.

Il paziente viene invitato a indossare mascherina chirurgica e guanti monouso, qualora le sue condizioni cliniche lo consentano e senza determinare ritardi nell’isolamento.

Il paziente viene accompagnato immediatamente nel locale individuato per l’isolamento temporaneo mantenendo una distanza minima di due metri, evitando qualsiasi contatto fisico e impartendo indicazioni affinché non tocchi superfici, arredi o altre persone.

La porta del locale di isolamento deve essere aperta dall’operatore e non dal paziente.

Gestione dell’area di isolamento

Il locale individuato per l’isolamento temporaneo deve essere immediatamente reso inaccessibile a persone non autorizzate.

All’esterno deve essere apposto un cartello con la dicitura:

ACCESSO VIETATO AI NON AUTORIZZATI – CASO SOSPETTO AGENTE BIOLOGICO

L’area antistante il locale deve essere temporaneamente interdetta al transito di utenti e operatori non coinvolti nella gestione del caso.

Nelle immediate vicinanze deve essere predisposta un’area per la decontaminazione tecnica e la svestizione, dotata almeno di:

- guanti medicali monouso;
- soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani;
- telini assorbenti impermeabili;
- contenitori per rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- disinfettanti idonei;
- contenitori rigidi per i DPI riutilizzabili destinati a sanificazione.

Valutazione clinica

Prima di accedere al locale di isolamento, il personale sanitario incaricato effettua la vestizione completa con DPI NBCR secondo le procedure aziendali vigenti.

La valutazione clinica deve essere pianificata preventivamente con il medico di riferimento e con lo specialista infettivologo al fine di limitare il numero di accessi al locale di isolamento e ridurre il rischio associato alle procedure di vestizione e svestizione.

All'interno dell'area di isolamento vengono effettuate:

- rilevazione della temperatura corporea;
- rilevazione dei parametri vitali;
- valutazione clinica iniziale;
- raccolta dell'anamnesi epidemiologica.

Particolare attenzione deve essere posta alla ricostruzione di:

- Paesi visitati;
- date di permanenza;
- eventuali esposizioni a rischio;
- data di esordio dei sintomi;
- caratteristiche cliniche dell'esordio.

Se il paziente è stabile e paucisintomatico, il medico di riferimento contatta lo specialista infettivologo per la definizione del percorso assistenziale.

Per i Presidi che fanno riferimento alla SOC Malattie Infettive 2, il riferimento è il medico di guardia/reperibile delle Malattie Infettive Ospedale S. Jacopo Pistoia. Per i presidi che fanno riferimento alle Malattie Infettive 1, il riferimento è il medico di guardia/reperibile delle Malattie Infettive Ospedale Santa Maria Annunziata.

Paziente con condizioni cliniche gravi

Qualora il paziente presenti condizioni cliniche critiche o necessiti di interventi non effettuabili nel locale di isolamento:

- medico e infermiere intervengono esclusivamente dopo aver completato la vestizione con DPI NBCR;
- il personale del PS libera preventivamente l'area assistenziale individuata;
- nell'area non devono essere presenti altri pazienti né operatori privi di adeguati DPI;
- una volta stabilizzato il paziente viene immediatamente attivata la consulenza infettivologica.

Diagnostica

Devono essere privilegiati dispositivi monouso e apparecchiature portatili bedside, quali:

- POCT;

- ecografi portatili;
- apparecchi radiografici portatili.

Non devono essere effettuati esami diagnostici che comportino la movimentazione del paziente o dei campioni biologici all'interno dei normali percorsi ospedalieri, salvo specifiche indicazioni concordate con lo specialista infettivologo.

Per la conferma diagnostica e l'esclusione di altre patologie (es. malaria o altre febbri emorragiche) se, su indicazione dell'infettivologo, è necessario prelevare un campione ematico di sangue intero questo dovrà essere inviato al laboratorio INMI L. Spallanzani previo accordo telefonico al numero tel. 06 551701 attivo h24. Il confezionamento e il trasporto dovranno avvenire mediante sistema a triplo involucro secondo la normativa ministeriale vigente e secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 3482 dell'11/05/2026.

Il servizio preposto al trasferimento del campione è SVS di cui si riportano i contatti di riferimento: Centrale Operativa 0586 888888.

Trasferimento del paziente

Una volta completata la valutazione clinica e assicurata la stabilizzazione del paziente, il caso sospetto ad alto rischio viene trasferito:

- presso AOU Careggi per i pazienti adulti;
- presso AOU Meyer per i pazienti pediatrici.

Il paziente ad alto rischio di esposizione dopo l'esecuzione del prelievo e la stabilizzazione, previo contatto con il referente infettivologo per la Regione Toscana prof. Alessandro Bartoloni, Direttore della SOD Malattie Infettive e Tropicali di AOUC, viene trasferito, in base alle condizioni cliniche, presso le Malattie Infettive o la Terapia intensiva e sub-intensiva di emergenza e del trauma di AOUC.

Il trasporto in biocontenimento sarà effettuato dal 118/Protezione Civile secondo le procedure regionali vigenti.

Sanificazione tracciamento contatti

Tutti gli ambienti e i percorsi utilizzati dal paziente devono essere sottoposti a decontaminazione e successiva sanificazione secondo la Circolare del Ministero della Salute del 04/09/2019 con le modalità di seguito indicate.

Tutte le persone presenti nelle aree interessate devono essere identificate e registrate ai fini dell'eventuale contact tracing disposto dalle autorità sanitarie.

PAZIENTE TRASPORTATO DAL 118

Di norma il sistema di emergenza territoriale 118 trasferisce direttamente i casi sospetti ad alto rischio presso AOU Careggi o AOU Meyer.

Qualora, per instabilità clinica del paziente, si renda necessario il trasporto presso un Pronto Soccorso dell'Azienda USL Toscana Centro, il PS di destinazione deve essere preventivamente allertato.

Prima dell'arrivo del paziente devono essere predisposte le seguenti misure:

- sgombero della camera calda;
- interdizione del percorso di accesso;
- individuazione e preparazione dell’area di isolamento o della sala dedicata;
- predisposizione del personale con DPI NBCR completi.

Il paziente viene accolto da un’équipe già protetta con DPI adeguati e gestito secondo le medesime modalità previste per i casi in autopresentazione.

Una volta completata la stabilizzazione clinica, il paziente viene trasferito presso il centro regionale di riferimento appropriato.

Anche in questo caso tutti gli ambienti e i percorsi utilizzati, comprese le aree esterne, devono essere sottoposti a decontaminazione e successiva sanificazione secondo le indicazioni riportate di seguito.

DISPOSIZIONE SPECIFICA PER IL PS PEDIATRICO DI PRATO

I pazienti pediatrici che accedono al triage pediatrico e soddisfano i criteri di sospetto per MVE vengono accompagnati condotti in Sala di Decontaminazione accompagnati dal triagista del polo pediatrico facendo il percorso esterno con gli stessi standard di protezione previsti per i pazienti adulti.

In caso di stabilità clinica, nel locale preventivamente individuato per l’isolamento temporaneo, utilizzando il percorso esterno dedicato e applicando gli stessi standard di protezione previsti per i pazienti adulti.

In caso di stabilità clinica il minore può permanere in braccio al genitore o deambulare autonomamente in funzione dell’età.

In presenza di instabilità clinica il paziente viene trasferito in barella nell’area assistenziale individuata per la gestione dell’emergenza, secondo le procedure adottate per i pazienti adulti.

ATTIVAZIONE DEL PERCORSO SANITARIO IN BIOCONTENIMENTO

Come riportato nella Circolare del Ministero della Salute n. 4258 del 29 maggio 2026, nei seguenti casi è previsto il trasporto in biocontenimento presso l'Ospedale Nazionale di Riferimento INMI "L. Spallanzani" previo contatto con il centralino al numero 06551701 (disponibile h24):

- casi di MVE confermati dal test diagnostico,
- viaggiatori asintomatici in rientro dalla RDC e Uganda con esposizione ad alto rischio (tabella 2).

Per i soggetti sintomatici classificati come casi sospetti o probabili (Tabella 3), l'eventuale trasferimento in biocontenimento viene valutato caso per caso dal referente infettivologo per la Regione Toscana prof. Alessandro Bartoloni, Direttore della SOD Malattie Infettive e Tropicali di AOUC, in raccordo con gli specialisti dell'INMI L. Spallanzani.

SEGNALAZIONE E NOTIFICA DEI CASI

Il medico che assiste un paziente con MVE sospetta o probabile esegue immediatamente notifica mediante la compilazione della scheda di notifica. Oltre alla notifica, il medico che pone il sospetto diagnostico deve contattare telefonicamente il medico reperibile della Direzione di Presidio che

provvederà quindi a segnalare telefonicamente il caso al medico reperibile della UFC Igiene Pubblica e della Nutrizione.

TRACCIAMENTO DI PAZIENTI E VISITATORI CONTATTI DI CASO MVE

Come previsto nei casi di MVE sospetta o probabile il personale del PS provvede alla raccolta immediata dei nominativi dei pazienti e accompagnatori, presenti in PS nelle zone/locali in cui è transitato il caso sospetto, comunicano tali dati alla DSPO per la segnalazione all'UFC Igiene Pubblica e della Nutrizione.

SORVEGLIANZA DI OPERATORE CONTATTO AD ALTO RISCHIO DI CASO MVE

Secondo la Circolare del Ministero della Salute n. 4258 del 29 maggio 2026, sono considerati —esposti a basso rischioll tutti gli operatori sanitari che assistono un caso di MVE anche quando vengano utilizzati DPI adeguati. Per tale motivo il Direttore SO e il Coordinatore infermieristico/recnico sanitario devono effettuare tempestiva segnalazione di tutti gli operatori che hanno assistito casi sospetti o probabili di MVE alla UO Medicina Preventiva al fine di avviare il percorso di sorveglianza mirata post-esposizione, e alla DSPO per la segnalazione all'UFC Igiene Pubblica e della Nutrizione di Azienda USL Toscana centro.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare sono riportati nell'Allegato A:

DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE

Il virus Ebola è sensibile ad una vasta gamma di disinfettanti per uso ospedaliero utilizzati per la disinfezione di superfici resistenti, non-porose. Tutti i disinfettanti attivi su virus con envelope (come il virus influenzale, ad esempio) sono attivi sul virus Ebola. Per maggiore precauzione si richiede di usare i disinfettanti attivi anche su virus senza envelope (es. norovirus, rotavirus, adenovirus, poliovirus) che sono più resistenti ai disinfettanti. Il virus è, inoltre, sensibile alla inattivazione da parte della luce ultravioletta e all'essicamento; il virus Ebola può sopravvivere anche molte ore in presenza di materiale organico.

Di seguito si riportano le principali indicazioni per la sanificazione ambientale in linea con quanto riportato nella Circolare ministeriale n. 26116 del 4 Settembre 2019:

- Le superfici ambientali devono essere decontaminate giornalmente. Nell'assistenza a pazienti con Ebola utilizzare ipocloriti in soluzione corrispondente a 1000 ppm.
- Per il trattamento delle attrezzature privilegiare l'utilizzo di prodotti a base di cloro; ove non possibile (es. incompatibilità dell'attrezzatura con il cloro) prediligere, tra i prodotti autorizzati dalla ditta produttrice, l'utilizzo di quelli di documentata efficacia nei confronti di questa classe di virus.
- Qualora il paziente vomiti, tossisca o abbia perdita di altri liquidi biologici, l'area interessata dovrà essere sottoposta a disinfezione secondo il ciclo a tre tempi:

1- Disinfezione/decontaminazione dei fluidi

2- Pulizia/detersione

3- Disinfezione delle superfici e dei materiali venuti a contatto con i fluidi

Per la decontaminazione di spandimenti di sangue e altri liquidi biologici è da preferire un disinfettante a base di cloro prima di procedere alla detersione:

a) piccole macchie di sangue o di piccole perdite: prima della detersione procedere alla decontaminazione con soluzione di ipoclorito 500- 1000 ppm di cloro disponibile (contatto di due minuti prima di pulire con pannetti monouso da smaltire nei contenitori per rifiuti a rischio infettivo);

b) versamenti più grandi: prima della detersione procedere alla solidificazione con prodotto ad alto potere assorbente a base di cloro (10.000 ppm di cloro disponibile), da smaltire nei contenitori per rifiuti a rischio infettivo.

Dopo la detersione, effettuare una disinfezione finale con una soluzione di ipoclorito 1000 ppm.

È opportuno disporre di soluzione di ipoclorito 500/1000 ppm preparata quotidianamente.

RIFIUTI

I rifiuti prodotti durante la gestione di un paziente con MVE sospetta o probabile, devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291) e smaltiti in linea con le indicazioni della Circolare ministeriale n. 26116 del 4 Settembre 2019 riportate di seguito:

• Gli effetti letterecci riutilizzabili (cuscini, materassi) devono essere trasportati al centro deputato al trattamento con modalità dedicate e sicure (doppio sacco e contenitore dedicato) e successivamente trattati con cloro derivati.

• Tutto il materiale monouso venuto a contatto con il paziente deve essere imballato tal quale nell'area di produzione del rifiuto come rifiuto a rischio infettivo: sacco in plastica o contenitore per rifiuti taglienti e pungenti, chiuso all'interno di un contenitore rigido a tenuta di liquidi. Tale contenitore esterno dedicato potrà essere portato fuori dalla stanza solo previa chiusura ermetica e decontaminazione esterna con cloro derivati.

• Tutto il materiale biologico eliminato dal paziente (es. feci e urine) può essere smaltito attraverso il sistema fognario ospedaliero.

• I contenitori dei rifiuti non devono essere riaperti né riutilizzati.

LISTA DI DISTRIBUZIONE

- Dipartimento Emergenza Urgenza
- Personale Dipartimento Emergenza Urgenza
- Area Anestesia e Rianimazione
- Personale Area Anestesia e Rianimazione
- Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica
- Coordinatori, Infermieri e OSS dei PS e Area critica
- Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari
- Coordinatori, TSRM
- DSPO
- Coordinatore delle Centrali Operative 118 e Reti Territoriali
- Personale 111
- Dipartimento della Prevenzione
- Gruppo di redazione